

Parte 0 • Direção e visão geral da aula

Fonte-parte da aula “Desenvolvimento normal: dos 2 anos ao início da puberdade” (Dr. Diego Alves Rosa, Psiquiatria Prática, residentes de psiquiatria). Tese unificadora: o período é a história da transferência do volante da regulação (ambiente/pais → linguagem → funções executivas → grupo de pares). Slides em assertion-evidence: título é frase completa; o corpo traz só a evidência.

Documento de Direção (Camada 1)

Aula: Desenvolvimento normal: dos 2 anos ao início da puberdade

Plataforma: Psiquiatria Prática (identidade visual da plataforma manda; declarada só na execução, Camada 3)

Público: residentes de psiquiatria (adultos e infância), maioria sem formação prévia em desenvolvimento

Professor: Dr. Diego Alves Rosa

Fonte primária: Bee & Boyd, Lifespan Development, caps. 7 a 10

Posição no currículo: antecede a aula de adolescência (outro professor), que começa exatamente onde esta termina: o evento puberal

Status: decisões de direção FECHADAS em conversa anterior. Este documento formaliza; não reabre.

1. Transformação do público (o que a aula faz com o residente)

Antes: o residente enxerga "desenvolvimento normal" como uma lista de marcos para decorar e regurgitar em prova, desconectada da clínica. Sabe de cor "aos 2 anos junta duas palavras", mas não sabe o que deveria tirar o sono dele diante de uma criança de 2 anos.

Depois: o residente enxerga o período dos 2 anos à puberdade como uma única história com lógica interna, a transferência do volante, e consegue usar essa história como instrumento clínico: diante de qualquer criança, pergunta primeiro "de quem é o volante nessa idade, e como está indo a transferência?". Marcos deixam de ser lista e viram sintomas de um processo.

Prova da transformação: ao fim da aula, o residente consegue (a) reconstruir a narrativa dos 4 atos só com a sequência de títulos dos slides; (b) dizer, para cada faixa etária, o que é vigilância legítima e o que é ansiedade desnecessária; (c) explicar por que TDAH "aparece" aos 6 anos sem dizer que "começa" aos 6 anos.

2. Tese unificadora

O período dos 2 anos ao início da puberdade é a história da **transferência do volante**.

- Aos 2 anos, a regulação é quase toda **externa**: ambiente, rotina, corpo do cuidador. Os pais dirigem.
- Ao longo do período, o volante é transferido para dentro: linguagem interna, funções executivas, autoconceito.
- No fim do período, o volante está quase todo **internalizado** e parcialmente **entregue ao grupo de pares**.

Gancho clínico que sustenta a aula inteira: quase todo diagnóstico da psiquiatria infantil é falha, atraso ou desvio nessa transferência. Quem entende a transferência entende por que cada transtorno aparece na idade em que aparece.

3. Estrutura: 4 atos

Corte por **idade**, com domínios entrelaçados dentro de cada ato. Explicitamente NÃO seguimos o corte por eixo do Bee & Boyd (físico/cognitivo vs social/personalidade); os capítulos são fonte de conteúdo, não de estrutura.

Ato 1 (2 a 3 anos): o corpo que ganha símbolo

- Função semiótica: o salto de agir sobre o mundo para representá-lo.
- Explosão lexical: a linguagem chega como ferramenta nova e ainda externa.
- Birra como fisiologia da regulação externa: não é patologia, é o custo de ter um sistema límbico funcionando sem freio pré-frontal; o freio ainda é o adulto.
- **Contracena clínica (vigilância):** a janela do TEA. Âncora no contraste funcional do apontar: apontar para PEDIR preservado, apontar para MOSTRAR (compartilhar atenção) deficiente. Janela do segundo ano, nunca idade rígida.
- **Pergunta que fecha o ato:** essa criança que agora fala e representa o mundo... ela sabe que os outros também têm um mundo dentro da cabeça?

Ato 2 (3 a 5 anos): a mente que descobre outras mentes

- Teoria da mente: crença falsa, a descoberta de que o outro age pelo que acredita, não pelo que é verdade.
- Fala privada de Vygotsky: a linguagem sendo puxada para dentro, o volante em trânsito.
- Erikson: iniciativa vs culpa, a criança que agora propõe e testa.
- **Contracena clínica (vigilância):** gênese funcional do TOD (resistir funciona: a oposição é comportamento aprendido num sistema de reforço, antes de ser rótulo) e sinais precoces de TDAH pré-escolar.
- **Pergunta que fecha o ato:** essa mente que descobriu outras mentes vai ser jogada num ambiente que exige tudo isso ao mesmo tempo, sem a mãe por perto. O que acontece?

Ato 3 (5 a 7 anos): a grande virada

- O shift 5-7: a reorganização cognitiva que várias tradições descrevem com nomes diferentes (Piaget: entrada no operatório concreto; processamento de informação: salto de velocidade, memória de trabalho e funções executivas).

- Escola como primeiro ambiente que exige autorregulação SEM co-regulação disponível.
- **Ponto dramático do ato (e da aula):** TDAH não aparece aos 6 anos. Fica visível aos 6 porque a demanda subiu antes de o freio ficar pronto. A curva de exigência cruza a curva de maturação.
- **Contracena clínica (vigilância):** embutida no ponto dramático (visibilidade do TDAH; diferenciar imaturidade esperada de desvio).
- **Pergunta que fecha o ato:** essa criança que agora se autorregula na escola... o que ela faz quando se olha no espelho e se compara com os colegas?

Ato 4 (7 anos ao início da puberdade): o eu comparado

- Autoconceito psicológico e comparativo: de "eu tenho um cachorro" para "eu sou tímida, menos boa em matemática que a Júlia".
- Amizade recíproca: o par como confidente e espelho.
- Moral saindo da heteronomia: regra deixa de ser sagrada porque o adulto mandou.
- Grupo de pares assumindo parte do volante: aceitação e rejeição como forças regulatórias reais.
- Pré-púbere sentindo o corpo começar a mudar.
- **Contracena clínica (vigilância):** rejeição por pares e retraimento como preditores; ansiedade e depressão ganhando cara escolar; o corpo que muda antes da turma como fator de risco.
- **Fecho em cliffhanger:** a puberdade não é o próximo capítulo, é um terremoto: sacode o carro inteiro, volante incluído. Essa história é a próxima aula.

4. Dispositivos didáticos (fechados)

1. **Personagem única: Alice.** Atravessa os 4 atos em cenas de consultório, narradas pelo professor. Alice é sempre a MESMA criança em idades diferentes; as cenas mostram desenvolvimento normal, nunca diagnóstico. Alice não vira paciente-caso: ela é a régua do normal contra a qual as contracenas de vigilância fazem contraste.
2. **Tração serial:** cada ato fecha com uma pergunta que o ato seguinte responde (perguntas listadas na seção 3).
3. **Contracena clínica em formato de vigilância:** "o que nessa idade deveria te tirar o sono?", nunca lista de transtornos com critérios. Critérios e listas ficam para as aulas de psicopatologia.
4. **Slides assertion-evidence:** título é frase completa que carrega a tese do slide; a sequência de títulos, lida sozinha, reconstrói a narrativa inteira (a aula funciona sem som); o corpo do slide traz a evidência (imagem, gráfico, esquema, clipe). Detalhes finos vão para o documento de apoio, não para o slide.
5. **Três tipos de vídeo,** cada um com slide-moldura antes (pergunta) e depois (síntese):
 - **Tipo 1, experimentos clássicos:** teste do espelho; Sally-Anne; conservação errada e depois certa (como antes-e-depois do shift 5-7); delay of gratification COM a ressalva das replicações (Watts et al.: efeito encolhe com controles).

- **Tipo 2, DNPM normal documentado:** clipes de 15 a 30 segundos, um por ato, de acervo público.
- **Tipo 3, cena natural sem função científica:** técnica exibir-congelar-perguntar-reexibir, para treinar análise funcional ao vivo.
- **Regra absoluta:** nunca vídeo de paciente do professor; só acervo público.

1. **Frenteira final ancorada no evento puberal, não em idade.** Anunciado na abertura: "esta aula termina quando o corpo da criança decidir, não quando o calendário decidir".

Refinamentos de direção (revisão criativa, não alteram as decisões fechadas):

1. **A mãe como régua escondida.** Nas cenas da Alice, a posição da mãe é o estado da transferência: aos 2 ela responde POR Alice; aos 4 consulta ("devo me preocupar?"); aos 6 é a garagem onde o freio esfria; aos 9 é plateia silenciosa; no cliffhanger, espera do lado de fora. Não anunciar; revelar só no fecho ("repararam que a mãe foi saindo de cena?").
2. **Painel do volante.** Diagrama recorrente (pais → linguagem → freio interno → grupo) que reaparece no fecho de cada ato mostrando o quanto do volante já migrou. Dá marcador visual de progresso à tese; especificação na Camada 2, estética na Camada 3.
3. **Espelho abertura-fecho.** O mapa "onde cada diagnóstico mora na transferência" (abertura) reaparece idêntico no fecho, agora legível pela plateia. A aula prova a si mesma.
4. **Apostas da plateia.** Três momentos de palpite explícito antes de revelação (idade do acerto na crença falsa; resposta da criança de 5 na conservação; por que a fila do TDAH começa aos 6). Adulto aprende mais depois de apostar.

5. Fonte e sacrifícios

- **Fonte:** Bee & Boyd, Lifespan Development, caps. 7 a 10 (PDFs de referência). Terminologia e evidências ancoradas no livro; páginas citadas no documento de apoio.
- **Sacrificado de propósito:** nutrição, obesidade, escolarização americana (estrutura escolar dos EUA, testes padronizados, segunda língua). Se um residente perguntar, resposta em aula, não slide.
- **Complementos externos ao livro, admitidos apenas onde a direção exige:** ressalva das replicações do marshmallow (Watts, Duncan & Quan, 2018), contraste funcional do apontar na vigilância do TEA (literatura de atenção compartilhada, ex. M-CHAT), leitura funcional do TOD. São contracenagens clínicas, não conteúdo de desenvolvimento; o livro continua sendo a fonte do normal.

6. O que esta aula NÃO é (limites de escopo)

- Não é aula de psicopatologia: nenhum transtorno recebe critérios, epidemiologia ou tratamento.
- Não diagnostica Alice: ela permanece normal do início ao fim.
- Não entra na puberdade: o evento puberal é a parede final; a aula seguinte (outro professor) começa nela.
- Não cobre 0 a 2 anos: assume-se aula anterior de primeira infância.

7. Pipeline e checkpoint

- **Camada 1 (este documento):** direção. Aprovação do professor destrava a Camada 2.
- **Camada 2 (arquiteto-de-slides):** spec slide a slide, sem decisão visual.
- **CHECKPOINT obrigatório:** revisão humana da spec da Camada 2 ANTES da fase pesada de construção do deck. Motivo: a sequência de títulos é a espinha da aula; corrigir título depois do deck pronto custa caro.
- **Camada 3 (identidade visual):** declarada pelo professor só na hora da execução. Nenhuma decisão de cor, fonte, template ou contagem estética aqui.

Regras e elementos estruturais dos slides (Camada 2)

Arquitetura de Slides (Camada 2)

Abertura da aula (slides S1-S4)

S1 · Capa

- Título: **Desenvolvimento normal: dos 2 anos ao início da puberdade**
- Subtítulo-tese: A história da transferência do volante
- Corpo: identificação do professor e da plataforma.

S2 · Tese

- Título: **Aos 2 anos, quem regula a criança é o mundo em volta; no fim desta história, o volante está quase todo por dentro, e em parte com os amigos.**
- Corpo: linha do tempo dos 4 atos (2-3, 3-5, 5-7, 7-puberdade) com o volante migrando: pais → linguagem → freio interno → grupo.
- Narração: apresentar a metáfora do volante e o teste que a prova: a MESMA birra no chão do mercado é fisiologia aos 2 e sintoma aos 9. O comportamento não mudou; o dono do volante mudou. Prometer que essa régua sustenta a aula inteira.

S3 · Gancho clínico

- Título: **Quase todo diagnóstico da psiquiatria infantil é falha, atraso ou desvio nessa transferência.**
- Corpo: os grandes rótulos (TEA, TDAH, TOD, ansiedade) posicionados sobre a mesma linha do tempo do S2, cada um no ponto onde a transferência costuma falhar.
- Narração: "você não vão decorar marcos hoje; vão aprender a perguntar de quem é o volante".

S4 · Contrato + personagem

- Título: **Esta aula termina num evento, não numa idade: quando o corpo de Alice começar a mudar, outro professor assume.**
- Corpo: apresentação de Alice (silhueta/ilustração em 4 idades). Regra anunciada: Alice é normal do início ao fim; ela é a régua, não o caso.

- Narração: anunciar fronteira puberal (decisão de direção 6) e a aula de adolescência que começa exatamente ali.

Apresentação da personagem Alice

A régua escondida (não anunciar até o S58): as cinco cenas têm uma segunda camada: a POSIÇÃO DA MÃE. Aos 2 ela responde por Alice; aos 4 pergunta se deve se preocupar; aos 6 é a garagem onde o freio esfria; aos 9 é plateia silenciosa; aos 11 espera do lado de fora. A mãe é o velocímetro da transferência. A revelação acontece na narração do S58, e costuma ser o momento em que a plateia sente a aula fechar.

Apresentação (S4): "Eu quero apresentar uma pessoa. Alice tem 2 anos hoje e vai fazer uns 11 até o fim da aula. Ela é rigorosamente normal, e vai continuar normal até o último slide; peço que ninguém diagnostique a Alice. Ela está aqui porque a gente só reconhece o desvio se tiver o normal de cor."

Plano de tempo

Versão completa, 90 min:

Bloco	Slides	Tempo	Nota
Abertura	S1-S4	6 min	Tese + contrato de fronteira + Alice
Ato 1	S5-S19	20 min	3 vídeos (espelho, birra T3, DNPM); a birra com congelamentos consome mais
Ato 2	S20-S32	17 min	2 vídeos + aposta na crença falsa
Ato 3	S33-S46	20 min	3 vídeos + ponto dramático; não correr no S39
Ato 4	S47-S57	18 min	1 vídeo + contracena + cena 5
Fecho	S58-S60	6 min	Revelação da mãe + take-home
Reserva		3 min	Transições e imprevistos

Versão enxuta, 60 min: cortar V3, V5 e V8 com suas molduras (9 slides a menos) e comprimir: abertura 5, Ato 1 14 (espelho + birra), Ato 2 12, Ato 3 14, Ato 4 12, fecho 3. As apostas ficam: custam segundos e seguram a sala.

Regra de ensaio: cronometrar os atos separadamente. Se algum ato passar 20% do previsto, o corte vem de conteúdo do MEIO do ato, nunca da cena da Alice, da contracena ou da pergunta de tração (são a espinha).